

7A. Mano-muñeca: anamnesis dirigida

Separar tendón, articulación, ligamento y nervio; en trauma, la radiografía puede pesar más que la ecografía.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿Le duele en la estiloides radial al usar el pulgar, hacer pinza o coger a un bebé?	De Quervain.	Reduce 1.er compartimento como generador.	Palpación, Finkelstein verdadero/WHAT y ecografía de vaina.
¿Se le duermen pulgar, índice y medio por la noche y mejora al sacudir la mano?	Túnel carpiano.	Reduce CTS típico, pero no lo excluye.	CTS-6, Durkan/Phalen/Tinel, sensibilidad y fuerza tenar.
¿Le duele la base del pulgar al abrir botes, girar llaves o hacer pinza?	OA CMC1/rizartrosis.	Reduce CMC1 sintomática.	Palpación, grind, pinza y RX.
¿Le duele el lado cubital al girar una llave, apoyarse o desviar la muñeca?	TFCC, DRUJ, ECU o carga ulnocarpiana.	Reduce patrón cubital mecánico.	Fovea/TFCC load, DRUJ y ECU dinámico.
¿Empezó tras una caída y duele en tabaquera o dorso radial?	Escafoides o lesión escafolunar.	Reduce trauma óseo/ligamentario, sin excluirlo.	Tabaquera, Watson, RX; inmovilizar si alta sospecha aunque RX inicial normal.
¿Se le bloquea o salta un dedo al flexionarlo y extenderlo?	Dedo en resorte/polea A1.	Reduce bloqueo mecánico de A1.	Palpar nódulo/salto y ecografía dinámica.
¿Ha perdido fuerza, nota atrofia, deformidad, herida o la articulación está caliente?	Déficit neural, rotura, fractura, infección o artritis aguda.	Reduce alarma inmediata.	Exploración neurovascular, RX/eco y derivación prioritaria.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

La distribución nocturna orienta al nervio mediano; la tarea de pinza localiza De Quervain o CMC1; tras trauma no se filtra antes de excluir fractura o inestabilidad.

7B. Mano-muñeca: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Finkelstein verdadero	Sujetar pulgar y desviar pasivamente la muñeca hacia cubital sin encerrar el pulgar en el puño.	Dolor focal en estiloides radial/1.er compartimento: apoya De Quervain.	Reduce De Quervain; no excluye fase leve. Evitar confundir con Eichhoff, más doloroso y menos específico.
WHAT	Muñeca en hiperflexión; paciente abduce/extiende pulgar contra resistencia.	Dolor habitual sobre 1.er compartimento: apoya De Quervain.	Hace menos probable De Quervain, sin excluirlo.
Phalen	Juntar dorsos de manos con muñecas flexionadas hasta 60 s.	Parestesias habituales en territorio mediano: apoya túnel carpiano.	No excluye; sensibilidad y especificidad son moderadas/variables.
Durkan	Comprimir directamente el nervio mediano sobre túnel carpiano hasta 30 s.	Reproduce parestesias mediano: apoya túnel carpiano.	No excluye. Integrar con síntomas nocturnos, fuerza tenar y sensibilidad.
Tinel mediano	Percutir suavemente sobre nervio mediano en túnel carpiano.	Descarga hacia pulgar-índice-medio: apoya irritación mediana; relativamente más confirmatorio que excluyente.	Negativo frecuente: no descarta túnel carpiano.
CMC grind	Estabilizar trapecio; comprimir axialmente el 1.er metacarpiano y rotarlo suavemente.	Dolor basal y crepitación: apoya OA CMC1 sintomática.	No excluye OA; correlacionar con palpación, pinza y RX.
Fovea / carga TFCC	Palpar entre estiloides cubital, FCU y pisiforme; añadir carga axial y desviación/rotación cubital.	Dolor cubital habitual: apoya lesión TFCC/ligamentos ulnotriquetrales, no una lesión específica.	No excluye TFCC; explorar DRUJ, ECU y solicitar imagen si cambia manejo.
Watson	Presionar tubérculo escafoideo mientras la muñeca pasa de desviación cubital-extensión a radial-flexión.	Clunk doloroso/dorsal y subluxación: sospecha inestabilidad escafolunar.	No excluye lesión; en trauma, RX y valoración especializada pesan más.

SÍNTESIS CLÍNICA

Túnel carpiano no se confirma ni se descarta con una sola maniobra: integrar distribución nocturna, Durkan/Phalen/Tinel, fuerza tenar y estudios electrodiagnósticos cuando cambien conducta. En trauma, no infiltrar antes de excluir fractura o inestabilidad.

7C. Mano-muñeca: ecografía, bloqueos y plan

La ecografía dinámica es especialmente útil en tendones, nervio mediano, gangliones y guía de vainas/articulaciones.

Plantilla ecográfica básica normal	Qué documentar
Nervio mediano	Morfología fascicular y área en entrada del túnel comparada con antebrazo; sin aumento focal. No diagnosticar por un único umbral.
Compartimentos extensores	Tendones centrados, fibrilares y móviles; sin líquido, engrosamiento ni tabiques relevantes en 1.º compartimento.
Flexores / poleas	Continuidad y deslizamiento; sin tenosinovitis. Polea A1 si dedo en resorte.
CMC1 / radiocarpiana / DRUJ	Derrame, sinovitis, osteofitos y cortical visible; correlacionar con RX.
ECU, ganglión y partes blandas	Estabilidad dinámica del ECU, quiste y relación neurovascular; el TFCC se valora solo parcialmente por US.

Escenario	Intervención posible	Regla práctica
De Quervain	Férula pulgar, carga y corticoide ecoguiado en vaina si persiste.	Identificar subcompartimentos; evitar inyección intratendinosa y advertir atrofia/hipopigmentación.
Túnel carpiano	Férula nocturna; corticoide ecoguiado para alivio corto o puente.	AAOS 2024: no aporta beneficio a largo plazo; déficit/atrofia o grave → cirugía.
Dedo en resorte	Infiltración en torno a polea A1 tras confirmar indicación.	Diabetes reduce respuesta y eleva glucemia; cirugía si bloqueo persistente/fracaso.
OA CMC1	Ortesis, adaptación de pinza y ejercicio; infiltración intraarticular seleccionada.	Beneficio variable y temporal; no repetir automáticamente.
Dolor cubital / lesión ligamentaria	Bloqueo articular diagnóstico solo si cambia conducta.	Inestabilidad o trauma concordante → mano/Trauma y RM/TC según sospecha.

MENSAJE AL PACIENTE

La infiltración puede calmar una vaina o un nervio, pero no corrige una inestabilidad ni sustituye la descompresión si ya existe pérdida de fuerza.

7D. Mano-muñeca: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
De Quervain / CMC1	Diclofenaco gel 11,6 mg/g; 2 g, 3-4 veces/día.	7-14 días junto a ortesis y adaptación de carga.
Brote articular	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250 mg/12 h si es seguro.	3-5 días.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días.
Túnel carpiano	Férula nocturna neutra; los AINE no descomprimen el nervio.	Ensayo 6-8 semanas si no hay déficit/atrofia.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
De Quervain	Triamcinolona 10 mg + lidocaína 1% 0,5 mL.	Total 1-1,5 mL en vaina; identificar subcompartimentos.
Túnel carpiano	Triamcinolona 20 mg + lidocaína 1% 0,5-1 mL.	Total 1-2 mL; fuera del nervio, alivio generalmente temporal.
Dedo en resorte	Triamcinolona 10 mg + lidocaína 1% 0,5 mL.	Total aproximado 1 mL alrededor de polea A1.
CMC1	Betametasona depot 0,25-0,5 mL o triamcinolona 5-10 mg + anestésico local.	Total 0,5-1 mL; confirmar posición intraarticular.

REHABILITACIÓN

Ortesis específica, movilidad y carga progresiva de pinza/agarre 6-8 semanas; terapia de mano 3-6 sesiones si precisa adaptación laboral.

EVITAR

Inyección intraneural o intratendinosa, repetir corticoide para túnel carpiano como solución a largo plazo o infiltrar antes de excluir fractura/inestabilidad.